RINDKERE NÕELDEKOMPRESSIOON (RNK)

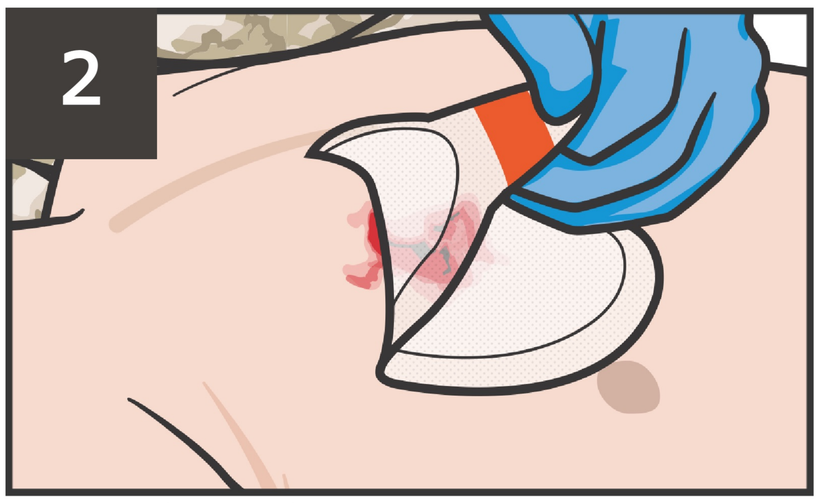
KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist

MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

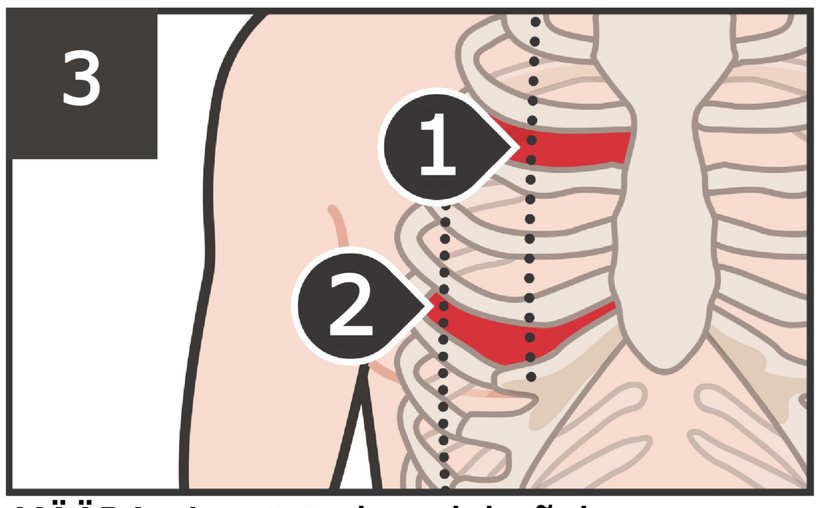
1

HINDA kannatanut pingelise õhkrinna (pneumotooraksi) tunnuste suhtes

MÄRKUS: Pingelise õhkrinna tunnuste hulka kuuluvad märkimisväärne kehatüve trauma või primaarne plahvatusvigastus, millele järgneb raske/süvanev hingamisraskus (hingamissagedus alla 8 või üle 20 hingetõmbe minutis või saturatsioon <90%)



Kui rindkere plaaster on eelnevalt paigaldatud, siis "röhitse" see või, kui esimene on valesti paigaldatud, VAHETA rindkere plaaster uue vastu Seejärel hinnake kannatanu seisundit uuesti

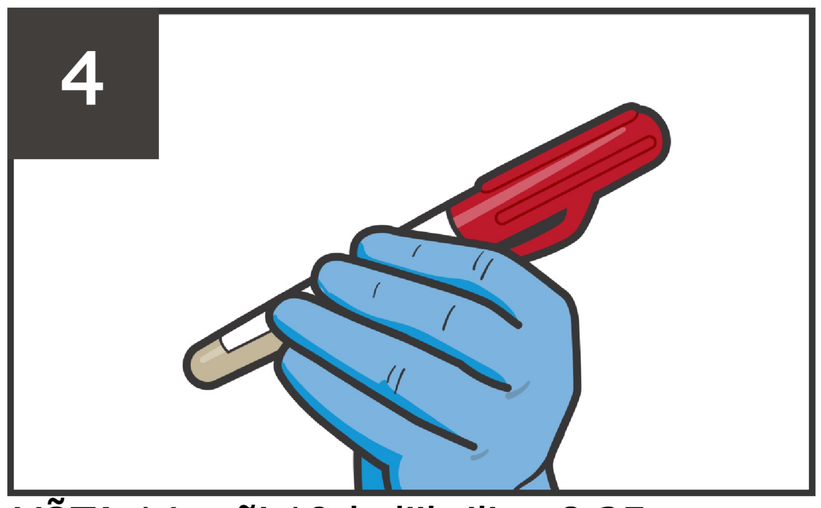


MÄÄRA vigastatud poolel nõela sisestamise koht (a või b - olenevalt sellest, kumb on ligipääsetavam)

1. Teine roidevahemik vigastud poolel rangluu keskjoonel

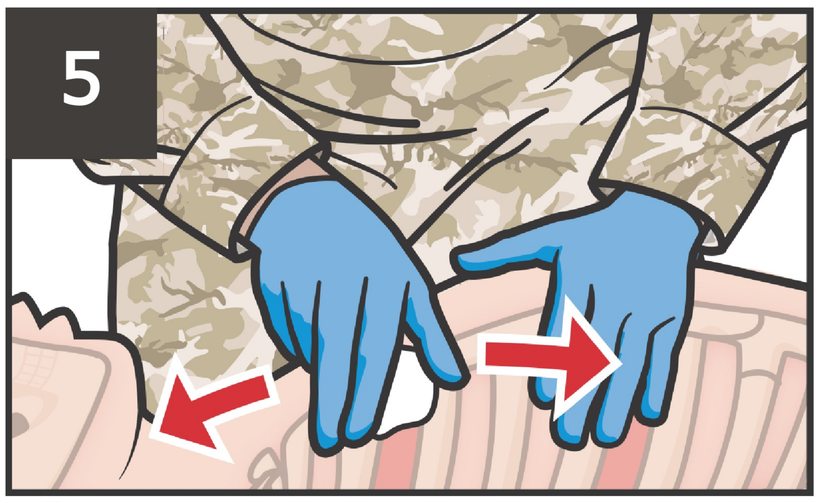
MÄRKUS: Ära sisestage nõela nibujoonest mediaalsemalt

2. Viies roidevahemik vigastud poolel eesmisel kaenlaalusel joonel

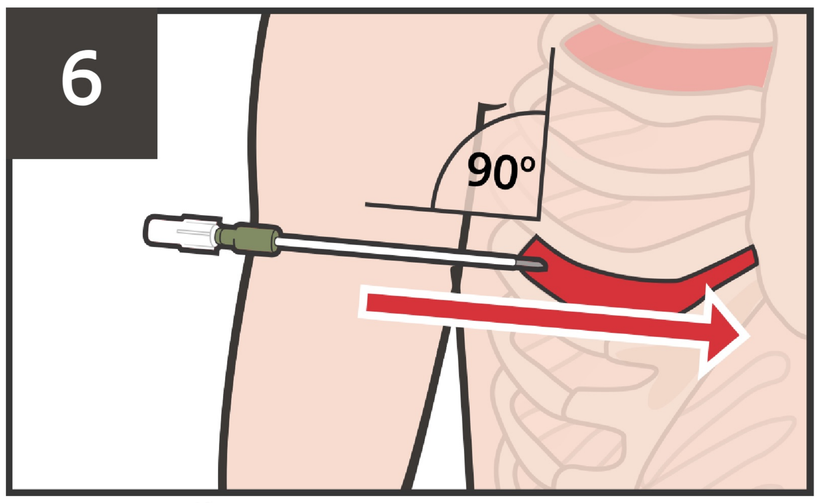


VÕTA 14- või 10-kaliibriline 8,25 cm nõel/kanüül

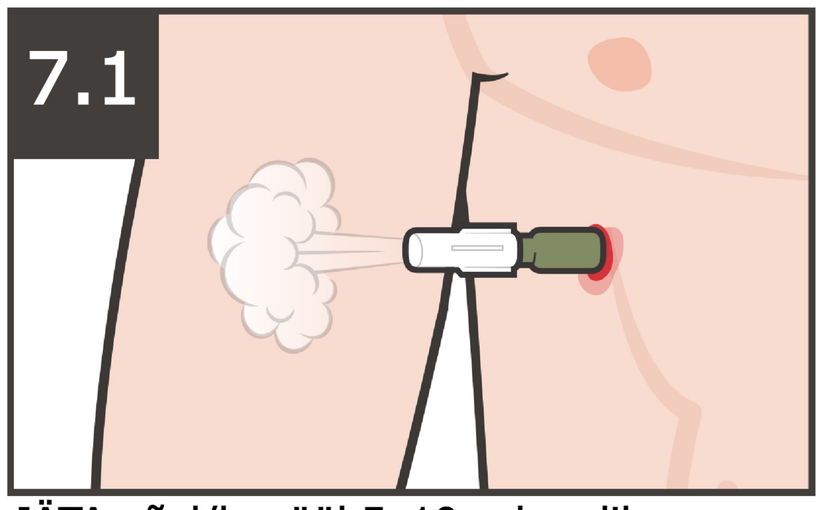
MÄRKUS: Eemalda nõelalt/kateetrilt Luer-luku kork (kui see on olemas)



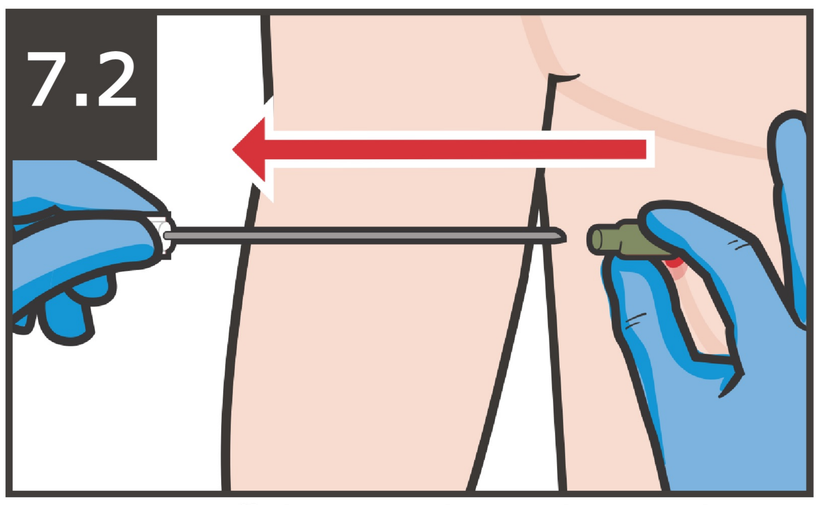
Võimalusel kasuta koha PUHASTAMISEKS antiseptilist lahust või lappi



Sisesta nõel/kanüül sisestamiskohas veidi üle alumise roide ülaosa, 90-kraadise nurga all (risti) rindkere seinaga, lükates seda sügavamale



JÄTA nõel/kanüül 5–10 sekundiks paigale, et toimuks dekompressioon



EEMALDA nõel, jättes kanüüli paigale

Eduka nõel-dekompressiooni HINDAMINE:

1. Hingamisraskus väheneb

2. Dekompressiooni teostamisel on kuulda selget susisevat heli, kui õhk rindkerest väljub

MÄRKUS: Seda võib olla raske hinnata kõrge müratasemega keskkondades

3. Saturatsioon suureneb 90%-ni või rohkem

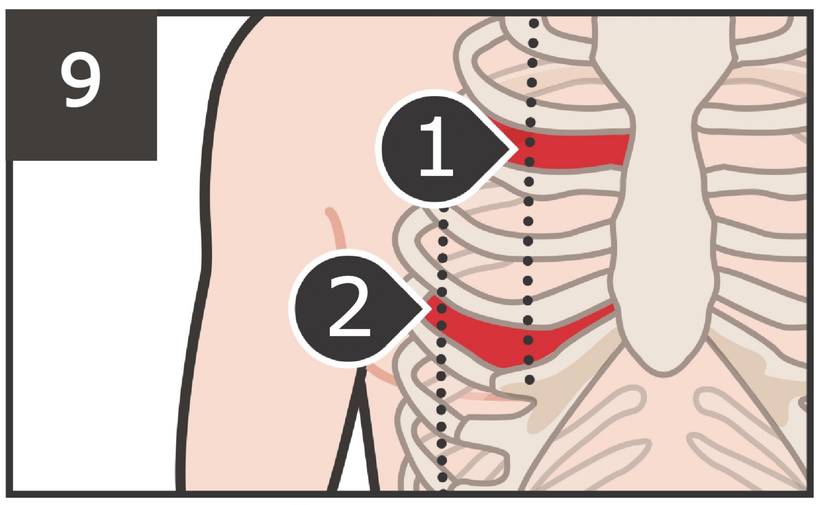
MÄRKUS: See võib võtta mitu minutit ja ei pruugi toimuda kõrgustes (nt. helikopteris)

Jätkub järgmisel lehel...

RINDKERE NÕELDEKOMPRESSIOON (RNK)

Jätkub...

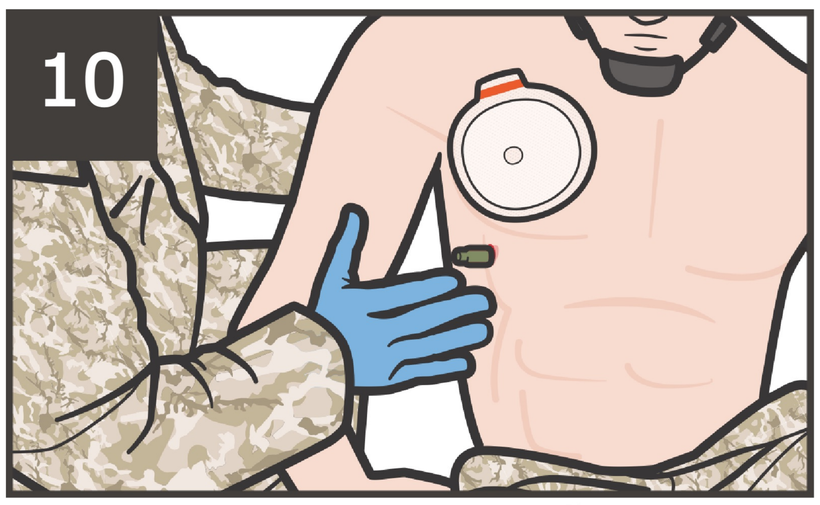
9



Kui esimene nõel-dekompressioon ei paranda kannatanu sümptomeid, siis TEHA teine dekompressioon samal rindkerepoolel, ükskõik millises kahest soovitatud kohast, mida varem ei kasutatud

MÄRKUS: Teisel dekompressiooni katsel kasuta uut nõela/kanüüli

10



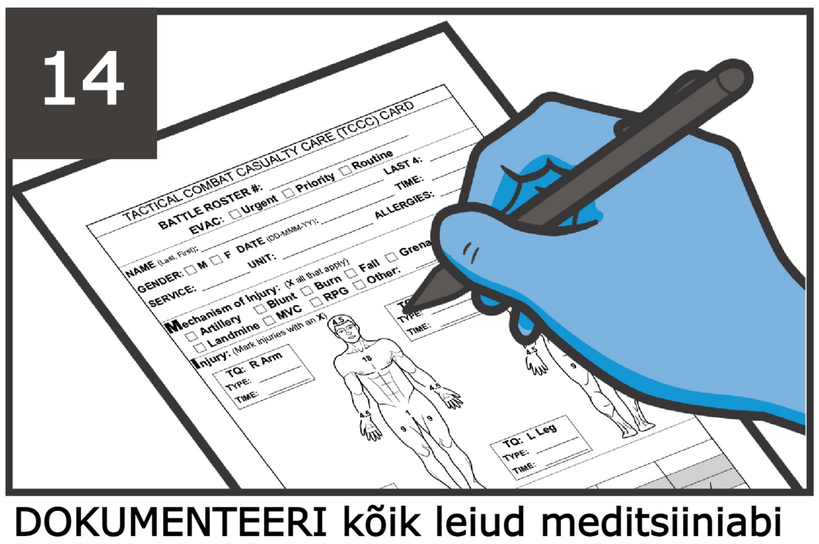
PANE kannatanu istuvasse või koomasendisse (vigastatud külg allapoole)

11 Jälgi kannatanu seisundit süveneva hingamisraskuse kordumise suhtes

12 Kui esialgne nõel-dekompressioon oli edukas, kuid sümptomid hiljem korduvad, siis TEE teine dekompressioon samas kohas, kus eelnevalt. Uue nõel-dekompressiooni jaoks kasuta uut nõela/kanüüli

13 Kui ka teine nõel-dekompressioon ei ole edukas, jätka MARCH (massiivne verejooks, hingamisteed, hingamine, vereringe, hüpotermia/pea) järjestuse vereringe (C) osaga

14



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge